# Control de anexos

## Finalidad y momento de uso

Registrar control de anexos en el momento de la actividad correspondiente a ODO-AN6. No usar datos simulados ni declarar ejecución únicamente por disponer del formato.

## Responsabilidad y preparación

La persona que realiza la actividad registra datos reales; el verificador revisa coherencia y evidencia según rol. Reunir instrucciones y soportes necesarios, confirmar identidad del objeto o usuario y usar acceso autorizado.

## Evidencia / requisito

Identificar documento auténtico, versión, origen y ubicación accesible al autorizado. La plantilla no sustituye licencia, manual original, certificado técnico ni prueba de ejecución.

## Aplica / fundamento

Diligenciar dato concreto y pertinente a control de anexos. Diferenciar observado, informado y pendiente; explicar no aplica cuando se justifica, sin usarlo para ocultar ausencia de evidencia.

## Estado / ubicación

Diligenciar dato concreto y pertinente a control de anexos. Diferenciar observado, informado y pendiente; explicar no aplica cuando se justifica, sin usarlo para ocultar ausencia de evidencia.

## Responsable / fecha

Registrar fecha y hora reales, periodo y secuencia cuando procede. No diligenciar retrospectivamente como si se hubiera realizado en otra fecha; las correcciones quedan trazables.

# Formato para diligenciar

Documento asociado: ODO-AN6 | Registro en blanco. Adjuntar hojas adicionales identificadas si se requiere.

| Evidencia / requisito | Aplica / fundamento | Estado / ubicación | Responsable / fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Observaciones y soporte vinculado

_____

_____

_____

# Criterios de revisión y custodia del registro

## Condiciones de entrada

Confirmar usuario, antecedentes, alergias, medicación, motivo y cambios clínicos. Relacionar indicación con diagnóstico y alcance de este documento. Verificar competencia, guía completa adoptada, equipos/insumos y ruta para complicaciones; si el riesgo supera capacidad, coordinar remisión.

## Decisión y preparación

Individualizar plan, sitio y técnica; informar riesgos y alternativas y vincular aceptación específica. Revisar instrumental liberado, productos vigentes y medidas de aislamiento. La decisión clínica requiere fundamento y no se deriva de una lista administrativa.

## Registro de ejecución

Describir lo observado y realizado en secuencia cronológica, con diente/sitio, técnica, medicamentos, materiales y lotes pertinentes. Documentar cambios de plan, eventos y acciones, vinculando registros de carga/paquetes. Evitar frases como sin novedad cuando hubo un hallazgo relevante.

## Registro no satisfactorio

Registrar la diferencia, proteger el área/usuario/material según riesgo y avisar al responsable. Establecer acción, plazo y comprobación posterior. En reprocesamiento una carga no conforme no se libera por urgencia de agenda.

## Archivo y correcciones

Identificar fecha, autor, versión y ubicación de anexos. Corregir por adenda o registro trazable sin borrar original. Custodiar con reserva si contiene datos de salud y asociar autenticación legalmente válida donde corresponda. El diseño no incluye campos de firma.

## Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

## Historia clínica y reserva

Resolución 1995 de 1999, artículos 3 a 5 y 11 a 14; Resolución 839 de 2017, conservación y reglas especiales. El diseño sin casillas de firma exige asociar autoría y aceptación válidas antes del uso clínico.

https://minsalud.gov.co/ihce/Paginas/Normatividad.aspx